

Ранняя диагностика рака яичников

Батырова Л. М.

Областной онкологический диспансер, г. Талдыкорган

Проблема распознавания злокачественных опухолей яичников является одной из наиболее трудных и нерешенных(1,3). Повсеместный рост заболеваемости раком яичников, высокие показатели смертности определяет актуальность и приоритетность этой проблемы.

Отсутствие патогномичных симптомов при ранних стадиях заболевания, широта возрастной группы заболевших женщин – все это представляет значительные трудности в диагностике рака яичников, поэтому больные чаще всего поступают в стационар на лечение в стадии диссеминации опухоли.(1,3,4,5,8)

Так, целью данного исследования является поиск наиболее эффективного сочетания комплексного обследования пациенток с подозрением на рак яичников.

Диагностика злокачественных опухолей яичников основана на использовании инструментальных и лабораторных методах исследования.

Основные задачи диагностики сводятся к:

- определение топика процесса (какой орган поражен);
- характер поражения (злокачественный или доброкачественный процесс);
- степень распространенности процесса;
- состояние организма (с целью определения возможности применения того или иного вида лечения).(2,4,7,9)

При обнаружении объёмного образования в области малого таза необходимо исключить такие заболевания, как дивертикулиты, внематочную беременность, кисты и доброкачественные опухоли яичника, миому матки, и эндометриоз. Следует помнить, что некоторые злокачественные новообразования, такие, как рак ЖКТ или молочной железы, могут метастазировать в яичники.(2,4,10)

С клинического обследования- начинается постановка диагноза: выяснение жалоб, сбор анамнеза и гинекологическое исследование.(1,5,6,10)

Наряду с анализом клинических данных применяется УЗИ малого таза. Этот метод- точен на 80-90 процентов, безвреден и многократно проводим при необходимости.(1,3,7) Для более углублённой диагностики при наличии опухолей яичников применяют такие высокоинформативные методы, как КТ и МРТ, ПЭТ. Диагностическая информативность МРТ в выявлении злокачественных опухолей яичника выше, чем УЗИ, КТ, показателя СА-125 в сыворотке крови и других клинических методов исследования.(4,7,8,9)

Возможность визуализации жизнеспособной опухолевой ткани и оценки ее биологической активности по степени интенсивности накопления в тканях метаболического РФП отличает ПЭТ от лучевой диагностики. ПЭТ обеспечивает возможность получения уникальной информации, в частности: достоверную дифференциальную диагностику злокачественных опухолей, доброкачественных новообразований и неопухолевых заболеваний; точное определение регионарной и отдаленной распространенности опухолевого процесса «во всем теле» и за одно исследование; объективную оценку эффективности проводимого лечения, а также раннее выявление рецидивов.(1,2,5,9)

Рентгенография грудной клетки — обязательный компонент обследования при подозрении на опухоль

яичников, так как позволяет диагностировать возможное метастазирование в лёгкие и плевральную полость.(2,6,10)

Выполнение лапароскопии или лапаротомии и получение материала для гистологического исследования является необходимым для постановки диагноза. Только гистологическая верификация диагноза может дать точный и окончательный ответ (1,3,8)

Определение маркеров опухоли яичников – опухолевых антигенов в частности -СА 125, не является решающим в постановке диагноза и учитывается лишь в сочетании с другими признаками рака.(4,8) Маркеры рака яичников могут быть повышены и при других заболеваниях, а также у беременных женщин.

С целью уточнения патогенеза опухолей и опухолевидных образований яичников, наряду используются такие современные методы исследования, как цитоморфологические, морфометрические, гистохимические.

Таким образом, согласно данным литературы, современная диагностика опухолей яичников не может базироваться на одном каком-то методе исследования, а требует целого комплекса диагностических мероприятий для установления факта наличия яичникового образования на ранних стадиях развития и проведения дифференциальной диагностики доброкачественного или злокачественного процесса, а также определения возможного морфологического строения опухоли.

Своевременная диагностика в значительной мере определяет успех современного лечения при раке яичников.

Список литературы

1. Абдуллаева Л.М., Бабаджанова Г.С., Турсунов Х.З., Назарова Д.Б. Клинико-морфологические особенности доброкачественных опухолей яичников // *Материалы V съезда онкологов и радиологов СНГ. Ташкент, 2008.* 372.
2. Автандилов Г.Г. Окулярная измерительная сетка для цито-, гисто- и стереометрических исследований // *Архив патологии. 1972. Т.34. №6.* 76-77.
3. Айрапетян Л.Г., Джилаян Г.А. Оценка некоторых прогностических факторов при лечении рака яичников // *Материалы V съезда онкологов и радиологов СНГ. Ташкент, 2008.* 373.
4. Антонеева И.И. Патогенетические аспекты прогрессии неоплазмы при раке яичников // *Материалы V съезда онкологов и радиологов СНГ. Ташкент, 2008.* 374.
5. Ахмедова А., Сергеева Н.С., Маршуткина Н.В., Мишунина М.П., Новикова Е.Г. Опухолеассоциированный антиген СА 125 в динамике у больных раком яичников при разных схемах лечения. // *Вопросы онкологии. 2003. 49. № 1.* 95-98.
6. Каирбаева М.Ж. Современные подходы к лечению рака яичников// *Здоровье и болезнь. – 2009. - №5(81).* - С.5-9.
7. Нугманов Э.У., Кайрбаев М.Р., Кукубасов Е.К., Каирбаева М.Ж.
8. Молекулярный маркер СА-125 в сыворотке крови больных раком яичников // *Терапевтический вестник. – 2009. - № 3 (23).* – С.302.
9. Жордания К.И. Некоторые аспекты диагностики и лечения рака яичников // *Онкология и гематология – 2003 - №10* – с 4-6.
10. Урманчеева А.Ф. Мешкова И.Е. Вопросы эпидемиологии и диагностики рака яичников // *Онкология и гематология – 2006- № 3-с 6-9.*
11. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии. Л., 1989.–464 с.